

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0258

Paginas del documento: 11

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

ance of elderly people, affecting
f the study population.
y person, fear of falling, functional

Resumen

Introducción: la población de edad avanzada ha aumentado significativamente desde finales del siglo XX. Ante este escenario, es necesario prestar atención a las caídas, dado el impacto negativo que tienen en la vida de las personas mayores. Ante esto, es importante estudiar el miedo a caer y su influencia en el desempeño funcional de las personas mayores.

Objetivo: evaluar la asociación entre el miedo a caer y la funcionalidad de las personas mayores de la comunidad.

Métodos: se trata de un estudio transversal, donde los participantes fueron elegidos por conveniencia, en el grupo etario mayor de 60 años. Los ancianos respondieron preguntas sobre su miedo a caer en situaciones cotidianas, utilizando la Escala Internacional de Eficacia de Caídas (FES-I - Brasil) y realizaron pruebas funcionales, como la Short Physical Performance Battery (SPPB), para evaluar el desempeño funcional; el Timed Up and Go Test (TUG), para evaluar el grado de independencia relacionado con la funcionalidad (equilibrio dinámico); y el Single Leg Support Test (TAU), para evaluar el equilibrio estático.

Resultados: participaron del estudio 62 ancianos, 53 mujeres y 9 hombres. El miedo a caer y la puntuación obtenida en el FES-I influyeron significativamente en el número de caídas sufridas y en el test Timed Up Go (0,03"). Según los hallazgos, se pudo detectar que el miedo a las caídas se asocia con la funcionalidad, reduciendo el grado de libertad e independencia funcional.

Conclusión: el miedo a caer puede influir en el desempeño funcional de las personas mayores, afectando la calidad de vida de la población de estudio.

Palabras clave: anciano, miedo a caer, pruebas funcionales.

Introdução

O envelhecimento, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, é definido como um processo de deterioração de um organismo maduro, comum a todos os seres de uma mesma espécie, de forma que o tempo diminui a sua capacidade funcional.¹ Segundo dados da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), demonstrou-se que 10,5% (303.017) da população do DF possuíam 60 anos de idade ou mais.² Em 2017, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registrou que o número de idosos ultrapassou a marca de 30,2 milhões no Brasil.³ Os dados evidenciam o crescimento da população idosa de forma acelerada desde o

pessoa idosa merece atenção. A principal causa das hospitalizações de pessoas acima de 60 anos de idade são as quedas, as quais possuem um elevado índice de ocorrências.⁵ A palavra queda é definida como o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior ao qual ele se encontrava inicialmente, determinado por circunstâncias multifatoriais que comprometem a estabilidade.⁶

A queda pode ocorrer por meio da instabilidade postural, que se caracteriza por alterações no equilíbrio corporal. O equilíbrio, por sua vez, é entendido como uma tarefa motora voltada ao planejamento e execução de padrões de movimento de forma a alcançar o controle postural.⁷ Esse controle postural é responsável pela manutenção do equilíbrio corporal. Para mantê-lo, o corpo utiliza três sistemas sensoriais: o sistema visual, o sistema vestibular e o sistema somatossensorial.⁸

O sistema visual permite ao indivíduo ver e processar informações sobre o ambiente e a localização, a direção e a velocidade de movimento de si próprio e de outros. O sistema vestibular fornece informações de referências que irão ajudar no controle da oscilação e do equilíbrio dinâmico. Por fim, o sistema somatossensorial é responsável por informações de contato e da posição corporal. Com o avanço da idade, esses sentidos são afetados, de forma que perdem parte de sua capacidade funcional. Como consequência, o equilíbrio corporal da pessoa idosa fica comprometido, aumentando as possibilidades de ocorrerem quedas.⁹

O Ministério da Saúde do Brasil define o medo de queda como uma preocupação constante sobre a possibilidade de cair.¹⁰ Esse fenômeno traz consequências negativas para a pessoa idosa, como, por exemplo, a falta de socialização, restrição de atividades, diminuição da qualidade de vida e preocupação exagerada. Todos esses fatores podem contribuir para a perda de funcionalidade ao longo dos anos.¹¹

O medo de cair entre idosos tem sido investigado

todos apontam que o medo de a prevalência global, conforme uma meta-análise que estimou uma taxa de 49,60%, sendo maior em países em desenvolvimento (53,40%) em comparação aos desenvolvidos (46,70%).¹² Esse medo de cair está associado a uma pior qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS), como mostram pesquisas realizadas na Europa, onde níveis elevados de medo de cair se correlacionaram negativamente com a QVRS, tanto física quanto mental.¹³ Ademais, fatores demográficos, como sexo e idade, desempenham papel relevante no desenvolvimento do medo de cair, com mulheres e pessoas mais velhas apresentando níveis mais elevados.¹⁴

Com base nos dados descritos, este estudo tem por objetivo correlacionar o medo de queda com os resultados obtidos em testes que avaliam a funcionalidade da pessoa idosa.

Métodos

Este estudo está associado ao projeto "Sarcopenia, desempenho físico funcional de membros inferiores e nível diário de atividade física de idosos submetidos a treinamento funcional com uso de aplicativo multimídia", nº do processo: 00193-00000178/2019-12, do edital 03/2018 – Seleção Pública de Propostas de Pesquisa Científica, Tecnológica e Inovação – Demanda Espontânea da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF).

Trata-se de um estudo transversal, do tipo quantitativo. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Católica de Brasília (UCB), sob número de CAAE: 69069417.2.0000.0029.

Amostra do estudo

Foram convidados a participar voluntariamente pessoas idosas de ambos os sexos, residentes no Distrito Federal (DF). Os participantes receberam uma explicação detalhada de cada

e, posteriormente, à assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Foi elaborado um formulário para o preenchimento pelos interessados em participar voluntariamente da pesquisa. O *link* e/ou o QR Code do formulário foram divulgados nas redes sociais, mídia televisiva, cartazes na Universidade Católica de Brasília (UCB) e na comunidade. Os voluntários foram escolhidos por conveniência após o preenchimento do formulário ou por indicação de um outro participante do projeto.

Crítérios de inclusão e exclusão

Como critérios de inclusão, estabeleceu-se: pessoas idosas na faixa etária igual ou superior a 60 anos de idade, de ambos os sexos, que conseguiram manter-se em posição ortostática com ou sem auxílio de dispositivo, e que estivessem vacinadas contra a COVID-19.

Foram excluídos os participantes que não atingiram pontuação mínima estabelecida para seu nível de escolaridade no Miniexame do Estado Mental (MEEM), de acordo com a nota de corte: 17 para analfabetos, 22 para 1 a 4 anos de escolaridade, 24 para 5 a 8 anos de escolaridade e 26 para >9 anos de escolaridade.¹⁵

Coleta de dados

A coleta de dados foi realizada no Laboratório de Avaliação Física e Treinamento da Universidade Católica de Brasília (LAFIT), no período de setembro de 2021 a fevereiro de 2023.

Os participantes receberam orientações para comparecerem com roupas confortáveis e calçado adequado para a realização dos testes. Foram aplicados o questionário sobre o perfil sociodemográfico, o medo de queda e, em seguida, foram realizados os testes funcionais detalhados abaixo.

Escala de Eficácia de Quedas Internacional (FES-I)

A Escala de Eficácia de Quedas Internacional

ações, as quais são atribuídas , notas que variam de 1 a 4, m pouco preocupado; 2 = um pouco preocupado; 3 = muito preocupado; e 4 = extremamente preocupado. O escore total varia de 16 a 64 pontos, sendo 16 = nenhum medo de quedas e 64 = extremo medo de quedas. Pontuações >23 sugerem associação com histórico de queda esporádica e >31 pontos pressupõem associação com quedas recorrentes.¹⁶ Para este estudo, os voluntários foram divididos em dois grupos: "com medo de queda" e "sem medo de queda". Utilizou-se as seguintes pontuações para a inclusão nos grupos: ≤ 23: não possui medo de queda; >23: possui medo de queda.

Short Physical Performance Battery (SPPB)

A Short Physical Performance Battery (SPPB) é utilizada para avaliação do desempenho funcional, sendo realizada em três etapas:

(1) Caminhada cronometrada de 4 m no ritmo normal do avaliado: o participante é orientado a se posicionar atrás da marcação inicial, posteriormente, é dado o comando do avaliador e então começa-se o teste. O cronômetro é pausado após o avaliado ultrapassar com os dois pés, a marcação final. A pontuação para essa etapa do teste será: 1 ponto, se o tempo for maior que 8,70 s; 2 pontos, se o tempo for de 6,21 a 8,70 s; 3 pontos se o tempo for de 4,82 a 6,20 s; e 4 pontos, se o tempo for menor que 4,82 s.

(2) Teste de sentar e levantar em uma cadeira: inicialmente, é realizada uma tentativa de sentar e levantar para verificar se o participante consegue realizar o teste. Se ele não conseguir, o teste é interrompido imediatamente. Caso contrário, é solicitado que ele execute a mesma ação por cinco vezes consecutivas, o mais rápido que conseguir, sendo que na última execução, deverá parar em pé. Não é permitido usar as mãos para ajudar a levantar-se, assim, os braços deverão ser cruzados sobre o tórax. A pontuação para essa etapa será: o ponto, se o participante não

tempo for de 13,70 a 16,69s; 3 pontos, se o tempo for de 11,20 a 13,69 s; e 4 pontos, se o tempo for 11,19 ou menos.

(3) Teste de equilíbrio de 10 s: o avaliado deve manter-se em pé, com os pés juntos, posteriormente, com um pé parcialmente à frente (semitandem) e em seguida, com um pé totalmente à frente (tandem), atingindo em cada posição o tempo de 10 s. A pontuação para "pés juntos" será 0 pontos, caso não tente realizar o teste ou não mantenha por 10 s; e 1 ponto, caso mantenha na posição por 10s. Para "semitandem" segue a mesma regra de "pés-juntos". Por fim, a pontuação "tandem" será de 0 ponto, caso não realize a etapa ou não consiga permanecer os 10 s; 1 ponto, caso mantenha por 3 a 9,99 s; e 2 pontos, caso mantenha por 10 s. assim, o total do teste de equilíbrio será de 4 pontos, no máximo.

A pontuação final é calculada por meio do somatório dos três testes, sendo possível atribuir nota de 0 a 12. A pontuação de 0 a 3 indica incapacidade ou capacidade ruim; 4 a 6 pontos: baixa capacidade; 7 a 9 pontos: capacidade moderada; e 10 a 12 pontos: boa capacidade.^{17, 18}

Timed Up and Go Test (TUG)

O Timed Up and Go Test (TUG) avalia o grau de liberdade e independência relacionada à funcionalidade. Sentado em uma cadeira, é ordenado que se levante e caminhe para a frente até uma marcação em uma distância de 3 metros. Em seguida deve-se retornar e sentar-se novamente na cadeira. Sugere-se que pacientes que consigam realizar o percurso em menos de 10s são classificados como totalmente livres e independentes; entre 10 e 19 s são independentes; entre 20 e 29 s demonstram dificuldades para as tarefas diárias; 30 s ou mais sugerem que o indivíduo tende a ser muito dependente para realizar tarefas básicas como: caminhar, levantar-se, alimentar-se, tomar banho.^{19, 20} De acordo pesquisas, o melhor valor preditivo para discriminar idosos que caíram foi 12,47 segundos.²¹

ostural estático foi avaliado de Apoio Unipodal (TAU). O participante é instruído a permanecer de olhos abertos, apoiado sobre o membro dominante, enquanto o membro contralateral deverá estar suspenso, realizando uma flexão de joelho a 90°. Não deverá segurar em nenhuma superfície para apoio, de forma que os membros superiores permaneçam relaxados. O participante deverá ficar no máximo 30 segundos. Caso haja desequilíbrio, o pé deve ser retornado ao chão ou o paciente apoiado em algo; nesse caso, o tempo é pausado e anotado. São realizadas três tentativas, considerando-se a média das três.²²

²³ Utilizou-se apenas as medidas do membro dominante. Assim como no estudo de Freitas et al., considerou-se o tempo entre 21 e 30 segundos para que a pessoa idosa fosse considerada sem nenhuma alteração de equilíbrio.²⁴

Análise Estatística

Os dados foram colocados em uma planilha

software SPSS 22.0. Para a análise descritiva dos dados foram utilizadas médias, desvios e frequências. Em seguida, foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk e constatou-se que a amostra era não paramétrica, com exceção do TUG, sendo assim, foi rodada comparação entre grupos com medo de cair e sem com o teste "U" de Mann-Whitney para as variáveis não normais, já para o TUG foi utilizado o teste "t" para amostras não pareadas. Para correlação dos dados utilizou-se o teste de Spearman. Para todas as análises foi considerada significância de 95%. O nível de significância adotado foi $p \leq 0,05$ *.

Resultados

Participaram do estudo 62 pessoas idosas, com idade igual ou superior a 60 anos, residentes no Distrito Federal. A amostra foi composta majoritariamente por mulheres (85,5%) e por pessoas que se autodeclararam de raça mulata/parda/cabocla (51,6%) (**Tabela 1**).

Tabela 1 – Dados descritivos da amostra (n=62).

		Total absoluto	Total relativo (%)
Sexo	Feminino	53	85,5
	Masculino	9	14,5
Raça	Mulata/parda/cabocla	32	51,6
	Branca	18	29
	Preta	7	11,3
	Amarela/oriental	3	4,8
	Indígena	2	3,2
Atividade física	Sim	35	56,5
	Não	27	43,5
Quedas?	Sim	15	24,2
	Não	47	75,8

	Hipertensão	37	60
	Artropatias	25	40
	Diabetes Mellitus	15	24
	Osteoporose	13	21
	Câncer	10	16
	Depressão	10	16
	Doenças do coração	8	13
	Nenhum	8	13
	AVC	5	8
	Doenças do pulmão	3	5
	Hepatite	2	3
Intensidade	Não realiza	27	44
	Leve	11	18
	Moderada	24	39
	Intensa	0	0
Qual atividade?	Funcional	5	8
	Pilates	7	11
	Dança	2	3
	Ginástica	5	8
	Hidroginástica	6	10
	Musculação	2	3
	Tênis	1	2
	Caminhada	16	26
	Corrida	1	2
	Não pratica	27	44
Medo de cair	Sim	24	38,7
	Não	38	61,3
Possui risco?	Sim	9	14,5
	Não	53	85,5
Alteração de equilíbrio	Sim	32	51,6
	Não	30	48,4

Quando observamos a correlação entre o medo de cair, com os resultados obtidos na realização dos testes funcionais utilizados no

trabalho. O teste funcional TUG se correlacionou significativamente com a variável "medo de cair" (**Tabela 2**).

		TUG			
		n	Média	Desvio padrão	p
Medo de cair	Sim	24	10,19	±2,81	0,03*
	Não	38	9,81	±1,81	
		SPPB			
Medo de cair	Sim	24	10,29	±1,68	0,4
	Não	38	10,76	±1,05	
		Apoio unipodal			
Medo de cair	Sim	24	16,6	±10,34	0,1
	Não	38	20,14	±9,12	

O valor de p foi significativo ($\leq 0,05$) para as variáveis SPPB, N° de quedas e TUG. Para as variáveis FES-I x SPPB, observou-se uma correlação desproporcional: quanto maior a pontuação na FES-I, menor a pontuação na SPPB. Na correlação entre FES-I x Apoio Unipodal, também houve uma correlação desproporcional: a pontuação da FES-I sobe ao passo que a

pontuação do Apoio Unipodal diminui. Na correlação entre FES-I e número de quedas, a correlação foi proporcional, ou seja, na medida que o voluntário alcançou maior pontuação na FES-I, ele também apresentou maior número de quedas. Por fim, a correlação entre a FES-I e o TUG também foi proporcional (**Tabela 3**).

Tabela 3 – Correlações entre testes funcionais e número de quedas com a FES-I.

	p	r
FES-I x SPPB	0,01*	-0,3
FES-I x Apoio unipodal	0,5	-0,2
FES-I x N° de quedas	0,03*	0,8
FES-I x TUG	0,03*	0,2

Discussão

Na presente pesquisa foi possível verificar que mais da metade dos voluntários avaliados (51,6%) possui alterações de equilíbrio. No entanto, apenas 38,7% apresentam medo de cair e somente 14,5% possuem risco de quedas. Foi encontrada uma correlação positiva entre a FES-I e o número de quedas (0,03*), apontando a prevalência de quedas em pessoas idosas com pontuação >23

que quanto maior o "medo de quedas", maior o número de acontecimentos desse evento. Esse achado também é evidenciado no estudo de Pena et al.¹¹ A porcentagem de caídores encontradas nesta amostra foi de 24,2% (15 pessoas), as quais relataram ter sofrido pelo menos uma queda nos últimos doze meses.

No critério da liberdade e da independência,

UG". Os voluntários com maior S-I, consequentemente, foram realizar o Timed Up Go em um intervalo de tempo maior, demonstrando diminuição no grau de liberdade e independência funcional. Os dados obtidos assemelham-se aos resultados encontrados no estudo de Lopes et al., o qual indicou uma correlação moderada significativa da escala FES-I com a variável TUG ($r = 0,45738$), o qual, demonstrando que 15 a 20% das pessoas idosas com medo de cair, apresentam algum déficit de mobilidade.²⁵ Outro estudo, realizado apenas com mulheres idosas, apresentou achados em comum.²⁶ Foi descrito que as participantes com medo de queda demoraram mais tempo para a execução do teste do que as que não apresentavam algum medo de cair.

A capacidade funcional permite que a pessoa idosa se adapte aos seus problemas cotidianos, mesmo diante da presença de alguma limitação física, mental ou social.²⁷ Fiorio e Meneghini afirmam que pessoas idosas com maior independência em suas AVDs apresentam melhor mobilidade funcional e, consequentemente, menos risco de quedas.²⁸ No presente estudo, o "medo de cair" e o desempenho físico dos participantes verificado pela SPPB, não apresentaram correlação significativa direta ($p = 0,4$). De acordo com os resultados encontrados, o medo de cair esteve presente mesmo em pessoas idosas com bom desempenho físico. Contudo, há uma correlação significativa entre as variáveis "FES-I x SPPB", demonstrando que, de forma geral, quanto maior a pontuação da escala, menor a pontuação na SPPB. Dessa forma, a SPPB não sofreu influência da variável "medo de queda", mas sofreu influência da Escala de Eficácia de Quedas de uma forma geral. A literatura evidencia que o medo de cair afeta a capacidade funcional de longevos. O estudo de Moraes et al., realizado com 42 participantes, descreveu que aqueles que possuíam medo de queda foram influenciados negativamente no

neste estudo, possam ter sofrido influência de características dos participantes, como, idade, sexo, raça, se pratica atividade física ou não.

Com relação ao equilíbrio, Nascimento et al. destacam que o medo de cair afeta o equilíbrio corporal, uma vez que a pessoa idosa foca sua atenção em suas limitações, intensificando esse medo.³⁰ No entanto, no presente estudo, os achados não foram significativos para as variáveis "medo de cair x TAU" e "FES-I x TAU". A análise estatística dessas variáveis demonstrou correlação direta não significativa e fraca. Estudos evidenciam que o sedentarismo é um dos fatores associados às quedas.³¹ A prática regular de atividades físicas por pessoas idosas contribui para melhores pontuações nos testes de equilíbrio, em comparação àquelas que levam um estilo de vida sedentário.³² A queda, em si, é um dos vários elementos existentes que favorecem a redução das funções de vida diária das pessoas idosas.³³ De acordo com Silva, Oliveira e Alfieri, indivíduos que praticam caminhada regularmente apresentam melhor mobilidade funcional, maior qualidade de vida e melhora em alguns domínios corporais.³⁴ Dessa forma, é possível verificar que a prática recorrente de atividades físicas é uma excelente prevenção contra as quedas. Com base nos dados mencionados, é possível sugerir que a insignificância dos achados neste estudo pode estar associada à prática de atividades físicas, visto que 56,5% das pessoas idosas estudadas afirmaram praticar alguma atividade e destas, 26% praticam caminhada. Sendo assim, mais da metade dos voluntários avaliados se beneficia da prática frequente de atividades físicas.

Viana afirma que a queda é um fator presente em todas as faixas etárias; contudo, as pessoas idosas apresentam alterações estruturais e funcionais, além de doenças sistêmicas, que aumentam sua predisposição a acidentes.³⁵ A funcionalidade na velhice traz preocupações para a Gerontologia, uma vez que, quando comprometida, ela impossibilita a execução de atividades de vida diária (AVDs), trazendo

e queda compromete a vida da pessoa idosa. Entretanto, essa preocupação, segundo estudos, advém de outras causas multifatoriais, trazendo um alerta aos profissionais da saúde de que o olhar para com o idoso não deve se resumir apenas a uma particularidade (medo de cair), mas ao ser como um todo. Em um estudo com pessoas pós-AVC, realizado por profissionais da saúde em Taiwan, detectou-se que, à medida que o medo de queda aumentava, o desempenho na realização de movimentos de giro corporal a 180° e 360° diminuía significativamente, comprometendo a deambulação.³⁷ Almidani et al. apontam que pacientes com glaucoma geralmente apresentam piores escores em questionários sobre medo de cair.³⁸

Como limitações do estudo, aponta-se o desenvolvimento da pesquisa com uma amostra com diferença significativa na quantidade de participantes homens e mulheres, o que pode influenciar diretamente os resultados. Outra limitação foi a dificuldade de encontrar voluntários. Dessa forma, foi preciso estender a coleta de dados por um período maior.

Contudo, embora o presente estudo tenha apresentado limitações, seus resultados são de grande importância e sua colaboração é de grande valor para a Ciência. Ele tem implicações significativas para a prática geriátrica, uma vez que traz dados relevantes sobre medo de quedas e capacidade funcional em pessoas idosas. Por meio deste estudo, será possível pensar em estratégias para melhorar o grau de funcionalidade de pessoas idosas, com o intuito de diminuir a preocupação por parte desses em cair, e, assim, também adotar medidas para prevenir as ocorrências de quedas.

Conclusão

O aumento da longevidade da população brasileira abre espaço para um olhar mais atencioso com pessoas idosas. O envelhecimento

longa quantidade de anos, é necessário ter uma vida com qualidade.

As evidências deste estudo demonstraram que o *score* da Escala de Eficácia de Quedas Internacional (FES-I) está diretamente associado ao número de quedas sofridas no último ano, ou seja, quanto maior a pontuação nessa escala, maior a probabilidade de o participante possuir um histórico de queda recente. Altas pontuações na FES-I também demonstram baixo desempenho no teste Timed Up Go (TUG), demonstrando, assim, uma correlação significativa entre ambas as variáveis. O mesmo acontece com a SPPB. Ademais, os *scores* da FES-I não apresentaram significância com a variável TAU.

É possível concluir que pessoas idosas que têm medo de queda possuem um histórico de quedas maior do que aquelas que não têm medo de cair. Foram encontrados achados significativos de interferência do "medo de cair" no TUG. Assim, o presente estudo conclui que o medo de queda não influenciou todos os testes de funcionalidade, logo, os resultados obtidos no SPPB e no TAU não demonstraram pontuações fora da normalidade para a faixa etária dos voluntários.

Referências

1. Organización Panamericana de la Salud. Guia clínica para atención primaria a las personas mayores. 3. ed. Washington: Organización Panamericana de la Salud; 2003. 405 p.
2. Companhia de Planejamento do Distrito Federal. Pesquisa distrital por amostras de domicílio (PDAD). Brasília: Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão; 2018. 127 p.

6. World Health Organization. Step safely: strategies for preventing and managing falls across the life-course. Geneva: World Health Organization; 2021. 194 p.

7. Sandra MM. Avaliação do idoso: física e funcional. 3. ed. Santo André, SP: Gráfica Mali; 2010. 261 p.

9. Spirduso WW. Dimensões físicas do envelhecimento. Barueri: Manole Saúde; 2004. 490 p.

10. Ministério da Saúde. Manual para utilização da caderneta de saúde da pessoa idosa. Brasília: Secretaria de Atenção à Saúde; 2018. 96 p.

olítica de saúde. Brasília: Organização da Saúde; 2005. 60 p.

Letícia Portela de Lima

Pós-graduada em Fisioterapia Cardiopulmonar e Terapia Intensiva pela Faculdade CEAFI, em Brasília, DF, Brasil; fisioterapeuta pela Universidade Católica de Brasília (UCB), em Brasília, DF, Brasil.

Taynara Raquel Souza Menezes

Fisioterapeuta pela Universidade Católica de Brasília (UCB), em Brasília, DF, Brasil.

Fernanda Nelli Gomes Giuliani

Mestra em Gerontologia pela Universidade Católica de Brasília (UCB), em Brasília, DF, Brasil; graduada em Fisioterapia pela Universidade Metodista de Piracicaba, em Piracicaba, SP, Brasil. Doutoranda do programa de Pós Graduação em Stricto Sensu em Gerontologia da Universidade Católica de Brasília (UCB), em Brasília, DF, Brasil.

Karla Helena Coelho Vilaça e Silva

Doutora e mestra em Investigação Biomédica pela Universidade de São Paulo (USP), em São Paulo, SP, Brasil; graduada em Fisioterapia pela Universidade de Franca (UNIFRAN), em Franca, SP, Brasil. Residência em Fisioterapia Geriátrica pela Universidade de Franca (UNIFRAN), em Franca, SP, Brasil.

Letícia Portela de Lima

Universidade Católica de Brasília

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa

Quadra QS 7

Areal (Águas Claras), 71966700

Brasília, DF, Brasil

35. de Mattos Brito Oliveira Viana E. O medo de cair: um estudo da auto-eficácia em idosos portadores de mieloma múltiplo [dissertação]. [Brasília]: Universidade Católica de Brasília; 2008. 103 p.

Os textos deste artigo foram revisados pela SK Revisões Acadêmicas e submetidos para validação das autoras antes da publicação.